Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5010328-16.2024.8.21.2001/RS

AUTOR: NEUZA MARIA RODRIGUES DOS REIS

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

NEUZA MARIA RODRIGUES DOS REIS ajuizou ação ordinária em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, alegando possuir diagnóstico de **Mieloma Múltiplo (CID10-C90)**. Refere que, em razão de sua enfermidade, necessita fazer uso do medicamento **Lenalidomida 15 mg**. Requereu, em sede antecipatória do mérito, o fornecimento do medicamento pelo réu e, ao final, a procedência do pedido (evento 1, INIC1).

Deferida a gratuidade da justiça (evento 25, DESPADEC1).

Indeferida a tutela de urgência (evento 32, DESPADEC1), a parte autora interpôs agravo de instrumento que foi provido (processo 5012226-68.2025.8.21.7000/TJRS, evento 26, DECMONO1).

Citado, o réu contestou, pugnando pela improcedência da demanda, dada a ausência de comprovação dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF (evento 47, CONT1).

Apresentada réplica (evento 56, RÉPLICA1).

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de outras provas (evento 76, DESPADEC1), as partes não se manifestaram (eventos 80 e 82).

O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido (evento 92, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Decido.

<u>DA COMPETÊNCIA</u>

A questão da competência está superada pela tese fixada no RE 1.366.243/SC, Repercussão Geral - Tema 1234, publicado em 19/09/2024. Segue o trecho do voto relativo à competência, com redação alterada após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina:

> *I - Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.*

No ponto, houve a modulação de efeitos para aplicação aos processos ajuizados após a publicação do julgamento no DJE, que ocorreu em 19/09/2024:

> *Por fim, modulo os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), propondo que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.*

Ainda sobre a competência, o Ministro Relator, no voto vencedor, que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela União, definiu:

> *3) acolho parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.*

No caso, o ajuizamento do processo ocorreu em 02/10/2024 e o fármaco postulado não é incorporado ao SUS para a patologia da parte autora.

Assim, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual.

Verifica-se a regularidade do feito, a legitimidade das partes e sua devida representação, sem nulidades ou irregularidades a serem sanadas.

DO MÉRITO

Direito à Saúde

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu artigo 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde -, e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido a Apelação Cível nº 70050003987, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/07/2012.

Do tratamento postulado

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tratou dos requisitos para o fornecimento de medicamentos na via judicial, por meio dos Temas n°s 1234 e 6, que geraram as respectivas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, abaixo reproduzidas:

> *Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*
>
> *Súmula Vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

Através da edição o Tema nº 06, o STF fixou a tese de que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

> *(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;*
>
> *(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;*
>
> *(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;*
>
> *(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;*
>
> *(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e*
>
> *(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.*

Ainda, conforme a tese firmada no Tema 1234 do STF, estabeleceu-se que:

> *IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de* ***medicamento*** *pelo SUS. 4)* ***Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.*** *4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (Grifou-se)*

É importante ressaltar que, com início em outubro de 2024, o processo foi devidamente saneado de acordo com os relevantes Temas referentes ao fornecimento de medicamentos, bem como os documentos foram requeridos alinhados a essas deliberações.

Segundo laudo médico acostado ao feito (evento 23, LAUDO4), a parte autora é portadora de **Mieloma Múltiplo (CID10-C90)**, necessitando do uso do medicamento postulado, buscando evitar a progressão da doença e o risco de morte.

Entretanto, inobstante a prescrição do profissional que atende a parte, verifica-se que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, avaliou o pedido de incorporação do medicamento postulado, não sendo recomendado seu uso para a patologia da parte autora, decidindo, dessa forma, pela não incorporação no SUS, conforme dispõe a PORTARIA SCTIE/MS Nº 16, DE 11 DE MARÇO DE 2022:

Origem	Data da solicitação	Tipo de Tecnologia	Motivo da solicitação	Tema da Saúde	Nome da tecnologia	Indicação	Status	Demandante	Data da decisão
Interna	22/02/2024	Medicamento	Incorporação	Hematologia	Lenalidomida em combinação com rituximabe	Tratamento de pacientes com linfoma folicular previamente tratados	Incorporado	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde SECTICS	28/06/2024
Interna	26/11/2021	Medicamento	Incorporação	Hematologia	Lenalidomida	Pacientes com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de célulastronco hematopoiéticas	Não incorporação	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde SCTIE/MS	14/03/2022
Interna	26/11/2021	Medicamento	Incorporação	Hematologia	Lenalidomida	Terapia de manutenção em pacientes com mieloma múltiplo submetidos ao transplante de célulastronco hematopoiéticas	Não incorporação	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde SCTIE/MS	14/03/2022
Externa	08/07/2025	Medicamento	Incorporação	Hematologia	Lenalidomida	Tratamento de manutenção de pacientes com mieloma múltiplo recém-diagnosticado que foram submetidos a transplante autólogo de células-tronco.	Em análise	Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e	

Minist⌂rio da Sa⌂de
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde

PORTARIA SCTIE/MS Nº 16, DE 11 DE MARÇO DE 2022

Torna pública a decisão de não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a lenalidomida para pacientes adultos com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de células-tronco hematopoiéticas.

Ref.: 25000.173289/2021-49, 0025674386.

A SECRETÁRIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a lenalidomida para pacientes adultos com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de células-tronco hematopoiéticas.

Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de avaliação pela Conitec caso sejam apresentados fatos novos que possam alterar o resultado da análise efetuada.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SANDRA DE CASTRO BARROS

Desse modo, não estando comprovado pela demandante a necessidade e a adequação da medicação postulada, bem como não estando preenchidos os requisitos fixados pelos Temas 1234 e 6 do STF (itens "b", "c", "d" e "e"), a pretensão não merece acolhimento.

Saliento, por fim, que não restou demonstrado pela parte autora que o ato administrativo de indeferimento/não incorporação não está conforme as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

No mesmo sentido desta sentença é o parecer ministerial (evento 92, PROMOÇÃO1).

Por fim, não se pode ignorar que o STF deu ênfase que ficará sujeita a nulidade a decisão judicial que condenar o ente público à dispensação de fármaco sem a estrita observância dos requisitos estipulados nas teses mencionadas, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A DOENÇA QUE ACOMETE A POSTULANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem estar presentes de forma simultânea. No caso, além do pressuposto da urgência, o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada exige a demonstração minimamente segura do preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal quando da definição das teses dos Temas 6 e 1.234 de repercussão geral, notadamente aquelas envolvendo medicamentos não incoporados ao SUS. 2. Caso concreto em que, verificada ***a existência parecer da CONITEC no sentido de não incorporar o medicamento Lenalidomida para o tratamento clínico do diagnóstico de mieloma múltiplo (CID 10 C90.0)****, cumpria à parte autora - que ajuizou a demanda após a publicação dos acórdãos que apreciaram o mérito dos recursos representativos de controvérsia - demonstrar a ilegalidade no agir da Comissão ao decidir desfavoravelmente à incorporação. Ausência, ademais, de elementos científicos que atestem a eficácia e segurança do fármaco postulado para o tratamento da doença em questão, bem como a (in)existência de substituto terapêutico elencado no SUS. Decisão denegatória da tutela de urgência confirmada. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50504499020258217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 10-07-2025)[grifou-se]*

Dessa forma, em que pese as alegações médicas e a comprovada incapacidade financeira, entendo que não restou comprovado o direito alegado, sendo caso de improcedência.

Ante o exposto, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido ajuizado por **NEUZA MARIA RODRIGUES DOS REIS** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**.

Pela sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, que arbitro em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida no evento 25, DESPADEC1 (art. 98, § 3º do CPC).

Caso interposto recurso de apelação, cumpram-se as formalidades dos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do CPC e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Agendada a intimação eletrônica das partes.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 21/08/2025, às 14:52:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10089264095v9** e o código CRC **8503d90b**.